

Conhecimento Clínico para Indexação

1. Cardiologia Congênita e Evolução Pediátrica

- **Perfil Clínico:** Paciente pediátrico com histórico de cardiopatia congênita complexa, caracterizada por Comunicação Interatrial (CIA) e Comunicação Interventricular (CIV) de grande extensão.
- **Complexidade Respiratória:** Apresentou quadro grave de faringolaringotraqueobroncomalácea, resultando em múltiplas paradas cardiorrespiratórias (PCR) no histórico pregresso.
- **Intervenções e Sequelas:** Submetido a procedimentos de atriorrafia e ventriculoseptoplastia, além de traqueostomia (posteriormente revertida).
- **Status de Recuperação:** Evolução com desenvolvimento neuropsicomotor adequado e exames de imagem (eletrocardiograma e radiografia) dentro da normalidade. Persiste uma comunicação residual entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito.

2. Medicina Intensiva: Choque e Disfunção Multiorgânica

- **Quadro Agudo de Choque:** Descrição de choque hipovolêmico de etiologia hemorrágica secundário a hematúria maciça.
- **Interação de Comorbidades:** Paciente com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e Doença Arterial Coronariana (DAC) com stent prévio. Evolução pós-operatória de ressecção transuretral (RTU) por patologia vesical benigna.
- **Reabilitação Física:** Presença de déficit motor global e instabilidade postural, exigindo suporte contínuo para mobilidade.

3. Patologias Infecciosas em Contexto de Imunossupressão

- **Etiologia:** Paciente com Doença de Crohn sob regime de imunossupressão, desenvolvendo Tuberculose (TBC) miliar e pneumonia bacteriana concomitante.
- **Falência Respiratória:** Progressão para insuficiência ventilatória aguda e pneumotórax, necessitando de drenagem torácica de urgência.
- **Histórico Cardiovascular:** Antecedente de cirurgia de revascularização do miocárdio (CRM) com múltiplos enxertos (mamária e safenas).

4. Insuficiência Coronariana e Eventos Isquêmicos Agudos

- **Síndromes Coronárias:** Casos detalhados de IAM com e sem supradesnivelamento do segmento ST (IAMCSST e IAMSSST).
- **Padrões de Lesão:** Predomínio de doença multiarterial severa, envolvendo a artéria descendente anterior (ADA) e a coronária direita (ACD).
- **Gestão de Complicações:** Registros de choque cardiogênico refratário com necessidade de altas doses de vasopressores (noradrenalina), episódios de Edema Agudo de Pulmão (EAP) e óbitos em pós-operatório imediato de revascularização.
- **Disfunção Ventricular:** Frações de ejeção variando entre 14% (severa) a 40% (moderada), frequentemente associadas a aneurismas ventriculares ou vasculares (ex: aneurisma de artéria basilar).

5. Distúrbios de Condução e Valvopatias

- **Bradiarritmias:** Casos de Bloqueio Atrioventricular Total (BAVT) com instabilidade hemodinâmica, exigindo implante de marcapasso (MP) definitivo em caráter de urgência.
 - **Taquiarritmias:** Episódios de Fibrilação Atrial (FA) com resposta ventricular elevada em pacientes já portadores de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis.
 - **Patologia Valvar:** Estenose aórtica crítica tratada via valvuloplastia, complicada por baixo débito cardíaco e intercorrências abdominais (pneumoperitônio).
-

Atributos Técnicos para Treinamento de Modelos (Metadata)

- **Terminologia Padronizada:** Uso rigoroso de siglas como **ACTP** (Angioplastia), **VMI** (Ventilação Mecânica Invasiva), **IRC** (Insuficiência Renal Crônica) e **FE** (Fração de Ejeção).
- **Hierarquia de Gravidade:** Os dados permitem ao modelo distinguir entre quadros estáveis (acompanhamento pós-operatório tardio) e quadros críticos (choque refratário e cuidados paliativos).
- **Nexo Causal:** A estrutura facilita a correlação entre doenças de base (ex: Diabetes Mellitus tipo 2, Hipertensão) e o agravamento de desfechos cirúrgicos cardíacos.